

QUÉ SON

Las distorsiones cognitivas (Beck, Burns) son errores sistemáticos en el procesamiento de la información que amplifican el malestar y mantienen los pensamientos negativos. No son mentiras intencionales: son patrones automáticos que distorsionan la realidad de manera predecible y aprendida.

CATÁLOGO DE DISTORSIONES PRINCIPALES

Pensamiento todo-o-nada

Ver las cosas en blanco y negro, sin matices. "Si no es perfecto, es un fracaso."

Generalización excesiva

Un evento negativo se convierte en regla universal. "Siempre me pasa esto."

Filtro mental

Focalizar exclusivamente en lo negativo, ignorando por completo lo positivo.

Descalificar lo positivo

"Eso no cuenta", "tuve suerte", "cualquiera lo haría." Los logros no suman.

Lectura del pensamiento

Asumir que se sabe lo que otros piensan. "Sé que le caigo mal."

Catastrofización

Magnificar lo negativo. "Si me va mal, es horrible e insoportable."

Razonamiento emocional

"Lo siento, por lo tanto es verdad." La emoción se usa como evidencia.

Los "debería" / "tendría que"

Reglas rígidas sobre cómo uno mismo u otros deberían comportarse.

Etiquetado global

Asignar una etiqueta total. "Soy un idiota" en vez de "me equivoqué en esto".

Personalización

Atribuirse la responsabilidad de eventos externos sin base real.

DISTORSIONES MÁS FRECUENTES POR CUADRO CLÍNICO

DEPRESIÓN

- Pensamiento todo-o-nada
- Filtro mental
- Descalificar lo positivo
- Etiquetado global
- Razonamiento emocional

ANSIEDAD

- Catastrofización
- Lectura del pensamiento
- Sobrestimar el peligro
- Subestimar capacidad de afrontar
- Personalización

AUTOEXIGENCIA

- Debería/tendría que
- Generalización excesiva
- Todo-o-nada
- Descalificar logros
- Perfeccionismo rígido

CÓMO TRABAJAR CON DISTORSIONES EN SESIÓN

1

Identificar

Nombrar juntos la distorsión presente, sin juzgar al paciente.

2

Validar la función

¿Para qué sirvió ese patrón? ¿Cuándo fue útil o adaptativo?

3

Evaluar el costo

¿Qué le cuesta al paciente pensar así en el presente?

4

Generar alternativa

¿Cómo sonaría ese pensamiento sin la distorsión?

PRECAUCIÓN CLÍNICA

No usar los nombres de las distorsiones como etiquetas peyorativas con el paciente · Que el paciente aprenda a identificarlas no garantiza que las cambie: se necesita práctica sostenida · En trauma y depresión grave: no desafiar el pensamiento demasiado rápido, puede sentirse invalidante.